

4

人格と適応

151
教育心理

●ポイント

教育活動において人を理解しようとすることはきわめて重要であるが、その際、心理学上の様々な人格理論を知っておくことは大きな助けとなる。特に、人を取り巻くストレスに満ちた現代社会の中で、適応の困難さを訴える若い世代に耳を傾けるとき、人格と適応の問題は重要性を増してくる。この領域は教育心理の中でも頻出領域となっている。

人格の理論では、頻出の類型論を理解した上で、類型論の限界を克服した特性論とそれをベースにしている質問紙法を関連付けたい。また、作業検査法、投影法も測定法として重要である。そして、マズローの欲求階層説、適応機制、不適応行動、発達障害、ロジャーズの提唱した非指示的カウンセリング(来談者中心療法)が特に頻出である。学校教育への応用が期待される集団精神療法の比較的新しい技法についても理解を深めたい。

1 人格とは

人格とは、感情や思考なども含む広い意味での行動全般に時間的・空間的な一貫性を与えるものである。それはその人の身体や脳を指しているのではなく、その人らしい行動を生み出す主体としての精神的存在を指している。人格はラテン語のベルソナ(persona)を起源にもつ英語のpersonalityの訳語であり、元来は、劇で役者が他人を演ずる場合に使用した仮面を指していた。役者はベルソナをつけたことで、様々な人格を観衆の前に示すことができる。よって、ある程度の一貫性を前提にしつつも、表面的な可変性そして他者からの可視性を意味に含んでいると考えられる。

一方、類似した概念として性格が挙げられる。性格はギリシャ語の「刻み込まれたもの」を起源とする英語のcharacterの訳語である。したがって性格と表現する場合、個人差を生じさせる基礎的で固定的な面、特に感情や意志の側面を指すことになる。personalityはアメリカとイギリスの心理学でよく用いられるのに対し、characterはドイツやフランスで用いられることが多い。最近の日本の心理学はアメリカの影響を強く受けており、また、日常語の「人格者」といった表現に含まれるような道徳的、価値的意味を回避する目的もあって、**パーソナリティ**と片仮名表記されることの方が多くなっている。

人格も性格も、必ずしも目に見える形で実在するわけではないが、存在を仮定して考察してみると、人の行動や個人差を説明することに役立つことが多い。人

152
教育心理

格の問題は、個人差への関心の高まりをその背景としてもっており、「自分と他者では、行動や、感じ方が違うのは何が違うからなのか」という問いかけの繰り返しから、様々な人格理論が生み出されてきた。

2 人格の諸理論

人が行動を生み出すメカニズムを説明するために、多くの研究者が独自の理論を展開してきた。それぞれが人間理解という切実な欲求から生まれており、我々にとって意義深いものであるが、ここでは**類型論**と**特性論**の立場からの複数の学者の理論を取り上げ、説明していく。詳細は以下にそれぞれ解説するが、人の性格を色に例えるならば、類型論は暖色や寒色など大きくパターン分けをするのに対して、特性論は三原色を採り出してその組み合わせで様々な色を表現していく手法といえよう。

(1) 類型論

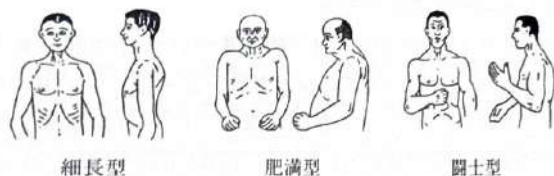
類型論は、人間の多様な性格を少数の典型的な性格像(型)に当てはめることで理解を容易にしようとする立場である。類型論では人格を全体としてまとまりをもつものと理解する。ある原理に従って典型が明示されるので、人格の全体像を直観的に把握することを可能としているが、そのことは、少数の型に当てはめることで中間型や混合型がとらえられない限界を意味している。また、人格形成や人格変化といった発達の・動的視点、人格に影響を及ぼす社会的要因が考慮されないという問題をもっている。

① クレッチマーの類型論

クレッチマーは精神医学の臨床上の経験から、統合失調症の人は細身の体格である割合が高く、躁うつ病の人は肥満である割合が高いことを認め、発病前の人格特徴(**病前性格**)と体格の関連性(図表4-1)に注目した。病前性格として分裂気質(**細長型**)と躁うつ気質(**肥満型**)を考え、てんかんの関連性からの粘着気質(**闘士型**)を加えて、3類型に分けた(図表4-2)。体格には上記3つの他に発育異常型などその他の類型も設定されており、精神病との関連はそれほど明確ではないともいえる。また、精神病の概念自体が時代とともに大きく変化しており、クレッチマーの類型論は研究史上の一里塚的存在と考えてよいだろう。

② シェルドンの類型論

シェルドンは正常な成人の身体の各部を測定し、消化器系の発達した**肥満型**の内胚葉型、骨や筋肉の発達のよい**中胚葉型**、神経系が発達して細長い体格の**外胚葉型**の3つに分けた。そして各型に対応する人格として、内臓緊張型、身体緊張



図表4-1 体格の類型の模式図

類 型	精神病	精神病質	正常者における気質と特徴
細長型	統合失調症 (精神分裂病)	分裂病質	分裂気質 非社会的、内気、きまじめ、変人、 臆病、過敏、神経質、恥ずかしがり、 従順、無関心、鈍感
肥満型	躁うつ病	躁うつ病質	躁うつ気質 社交的、親切、善良、温か味がある、 明朗、ユーモアがある、活発、平静、 落ち着いている、柔和
闘士型	てんかん	てんかん病質	粘着気質 鈍重、几帳面、固執的、情緒安定、 丁寧すぎる、真面目すぎる、自己主 張が強い、まわりくどい、興奮・激 怒しやすい

図表4-2 クレッチマーの類型論

型、頭脳緊張型を考えた。シェルドンの健常者におけるデータを基礎とする3類型は、クレッチマーの類型論を統計的に検討したものとして評価できるが、今日ではシェルドンが報告したような身体と人格との高い相関は認められていない。

③ ユングの類型論

フロイトの弟子だったことでも有名な分析心理学者のユングは、力動論的立場からこころの活動をエネルギー現象に例えた。フロイトはリビドーという概念を性的な欲望という意味で用いていたが、ユングはそれよりも広い一般的な活動源としての心的エネルギーとみなした。そして、リビドーが個人の外に向かいやすいか、内に向かいやすいかによって、**外向型**と**内向型**に分類した。外向型の人には、環境の影響を受けやすく、情緒の表出や行動化が自由で社交的である。内向型の人には、自己に関心が集中して内省的となり、行動も控えめである。さらに、これら向性の次元に意識の4つの基本機能である思考、感情、感覚、直感を付加して、それらの組み合わせにより8つの人格類型を考えた。この向性を個人的向性と社会的向性の両面から測定する質問紙法の検査として、50項目から成る**向性検査**が知られている。

④ シュプラングの価値観の類型論

哲学者のディルタイは個人がもつ世界観に基づいて官能型、英雄型、瞑想型の性格類型に分けた。彼の弟子である**シュプラング**は、人の6つの基本的な生活領域を考え、それらの中で、どの領域に最も価値をおき興味をもちながら生活しているかに従って6類型に分類した。理論型は事物を客観的にみる論理性や知識に価値をおいた。経済型は事物を功利性に従って判断し、審美型は繊細で美に価値をおいた。宗教型は神への奉仕を重視し、政治型は他人の支配を求め、社会型は人間愛や他者の成長に価値をおくとした。

⑤ シュナイダーの類型論

シュナイダーは、精神病質を次の10の類型に分けている。すなわち、発揚型、抑うつ型、気分易変型、爆発型、顕揚欲示型、自信欠乏型、熱狂型、意志欠乏型、情操欠乏型、無力型である。精神病質とは、シュナイダーによれば、素質的要因を含んだ極端な性格の歪みで、自己または社会を悩ますものとされる。したがって、一般のすべての人がこの類型のどれかに分類可能である訳ではない。



ABO式血液型も、それが性格と関連付けて述べられる際には人格の類型論の一つといえる。この説を血液型性格関連説あるいは血液型性格学という。「A型の人には神経質だ」というような両者の関係は、特に青年期の女性を中心として広く信じられている傾向にある。しかし、統計学的観点から多くの研究者がその妥当性の検討を試みているが、現時点では明確な関連性が認められないという結論が、関連の程度が極めて弱いかのどちらかである。

根拠をもたない強い思い込みをステレオタイプとよぶ。また、思い込みが現実にかわっていくことを**予言の自己成就(自己充足的予言)**という。このような情報を根拠として様々な意志決定がなされる状況は決して好ましくない。2004(平成16)年12月、放送倫理・番組向上機構(BPO)の青少年委員会は放送各局に要望書を提出し、「本人の意思ではどうしようもない血液型で人を分類、価値付けすることは差別に通じる危険がある。特に判断能力にたけていない子どもたちが固定観念を持つ恐れがある」と述べている。

(2) 特性論

特性論は、人格を構成する基本的要素を分析的手法で明らかにして、それぞれの要素ごとの個人差を組み合わせて人格全体を理解しようとするものである。前項の類型論では少数の型によって分類を行ったが、ここでは比較的多数の要素を取り上げてそれらの程度を視覚的に示す。この基本的要素の一つ一つを特性とよぶ。人格を理解する上でどのような特性をいくつ採用するのがよいかについて多くの学者が理論を展開してきた。一般に、特性を抽出する際には因子分析という統計的手法が用いられており、次節で取り上げる人格の測定法の中でも質問紙法は特性論を基礎としているものが多い。

① オルポートの特性論

人格特性という表現を最初に用いたのは**オルポート**であるとされる。この特性は直接観察することはできないが、行動を観察することで推測できる概念である。オルポートは一人の人格はこれらの特性の総和であると考えた。

彼は、辞書の中から人の人格に関係する単語を1万7千語以上抜き出し整理している。そしてこれらは、同一文化内での共通特性と、個人特性に大別された。さらに共通特性は、人が目標に向かって行動しているときに現れる表出的特性と、環境に適応しようとするときに現れる態度的特性に分けられた。そして最終的には、共通特性に含まれる多くの下位特性と、身体、知能、気質からなる心理生物学的基礎を測定して総合的に示す、**心誌(サイコ・グラム)**を作成した。さらにこの心誌という人格特性プロフィールを用いることで、性格構造における個人差と人格成長過程の把握を可能にした。

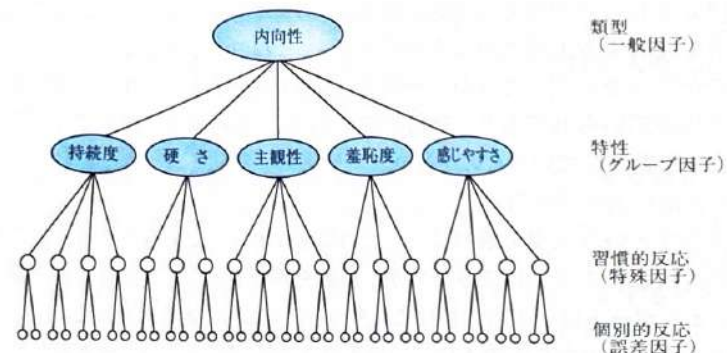
② キャッテルの特性論

性格心理学者で計量心理学者でもある**キャッテル**は、**因子分析法**を用いて特性を抽出した。人の行動特徴を記述した用語を、生活史、自己評定、客観テストを用いて多く収集し、それらを整理し35の**表面特性**を得た。そしてさらにそれらを用いて作成した成人男子に対する質問紙の結果を因子分析して、12の**根源特性**を見出している。キャッテルは、さらに研究を続けて4つの因子を加え、それをもとに16PF人格検査が作成された。

③ アイゼンクの理論

アイゼンクの理論は類型論と特性論を統合するものとして評価されている。彼は、精神医学的診断、質問紙検査、客観的動作テスト及び身体的差異について多角的に測定し、人格の基礎として生物学的個体差に着目しながら、**因子分析**を中心とした厳密な統計処理を加えた。その結果、特性よりも基本的な次元

として類型をおき、その下に特性、特性の下位に習慣的反応、さらにその下位に個別的反応の水準があるという階層構造(図表4-3)を考えた。彼の理論は内向性—外向性と神経症的傾向の2次元を測定する質問紙法の**MPI(モーズレイ性格検査)**の形で実用化されている。



図表4-3 アイゼンクの階層構造

④ ビッグ・ファイブ論(特性5因子説)

1980年代に入って、人格全体を理解する上で必要十分な特性の内容と数について再び注目されるようになった。多くの研究者が様々な観点から検討を重ねた結果、外向性(話し好き、陽気、社交的など)、情緒不安定性(不安、弱気、神経質など)、誠実性(計画的、勤勉など)、調和性(温和、寛大、親切など)、開放性(独創的、臨機応変、好奇心など)の5因子を基本的特性次元と考えることの妥当性が支持されるようになった。この5つの主要人格特性を**ビッグ・ファイブ**という。今後この理論に基づいた人格検査が標準化され、信頼度の高い理論の一つとして取り上げられるであろう。

以上のような特性論では、主に数学的根拠をもって、すべての人に共通する複数の人格特性の総和として人格全体を表現しようとする。このため各特性の程度の組み合わせから複雑な個人差を示すことを可能とし、また特性の程度は量的に示されることから数量的変化として人格変化を示すのにも適する。しかし、一人の人間の人格を分析的に示すことはかえってその人物像の把握を困難にするという問題ももち合わせており、それを克服するために、アイゼンクの発想のように、特性の組み合わせによって類型化して全体的な理解が図られるよう工夫することが重要である。

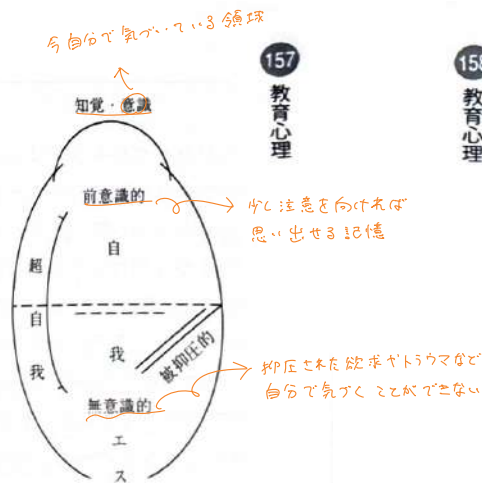
(3) 力動論(フロイトの理論)

精神分析学の創始者であるフロイトは無意識の発見者としてよく知られている。人間の活動は意識過程だけで完結しているのではなく、自分で気付くことのできない無意識的過程の作用を明らかにすることで、全体としての人間存在を因果論的に把握することができると考える。このように、意識や行動として表面に現れた現象が生じたメカニズムについて、無意識過程を含めて、どの力同士が作用し合っているかを考察していく立場を力動論という。フロイトは人格の構造としてエス(イド)、自我(エゴ)、超自我(スーパーエゴ)の3領域を挙げ、それぞれが独自の機能をもった全体として一つの心的装置であると考へた(図表4-4)。

エスは無意識の側面で、人間のあらゆる活動の源であるリビドー(性的エネルギー)の貯蔵庫であり、判断過程をもたない本能衝動の即時的短絡的な解放を目指した快感原則(快楽原則)に従って機能する。また、無意識は幼児期における観念などが抑圧されている領域でもあり、これは後に述べる神経症発症メカニズムに関わってくる。

自我は人格の中の意識的で知的な部分で、外的事実と精神内界を認知し、現実的合理的に適切な対応を図ろうとする現実原則に従って機能する。また、後述する自我防衛機制(適応機制)をもつかさどる領域である。

超自我は意識から無意識領域にまたがる存在であり、幼児期からの両親や社会のはたらきかけによって形成された道徳性や良心、価値観である。理想原則に従って完全性を望み、エスの衝動を抑制し、自我機能を道徳的な方向へ導こうとする。両立しないエスと超自我の衝突を調整し、現実に適応的な行動を選択する上で、自我のはたらきは重要である。これら3つの機能のバランスで個人差が説明されるが、自我の作用を超えてエスや超自我が他を圧倒すると、神経症などの不適応状態が生じると考えられる。



図表4-4 フロイトの心的装置

157
教育心理

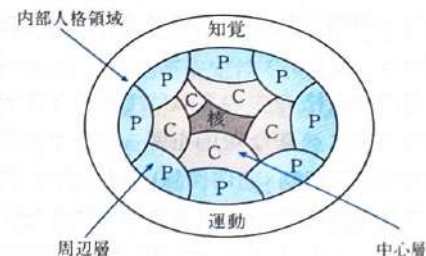
158
教育心理

(4) 場の理論(レヴィンの理論)

ゲシュタルト心理学では、全体は単に部分を寄せ集めたものではなく、意味のある全体として現れると考える。この立場の提唱者の1人であるレヴィンは、ゲシュタルト心理学の考えを人格理論に適用して場の理論を提唱した。人格は環境(場)から離れて存在するものではなく、常に環境との関係において理解されると強調し、行動の基本原則を $B=f(P \cdot E)$ という公式で示した。ここで、Bとは人の行動、fは関数、Pは人格、Eは環境を表す。

このような人と環境との相互作用という考えを基礎において、レヴィンは人格の構造を考えている。まず人格は内部人格領域と知覚・運動領域の2つで構成され、層構造をなしている。知覚では外界の情報がとらえられた後、内部の人格領域へ伝達されて緊張を生じ、それは内部の様々な領域を経由して再び外側の領域へ伝えられる。そして、最終的に運動として言語や行動の形で表出され、環境へのはたらきかけがなされる。この過程で生じる個人差(人格)について、レヴィンは内部人格領域の分化度と硬さの概念を用いて説明した。分化度が高いと人格は複雑で機能的分離が進んでいるため行動が洗練されている。また、硬さの程度が低いと各領域間の伝達度が高くなり緊張が他の領域に波及しやすく、行動は全反動的で短絡的になると考えたのである。

なお、場の理論は、行動の変容を説明するという観点からは学習理論の一つでもあり、ケーラーやトールマンと並んで認知説の一つとして位置付けられる。



図表4-5 場の理論からみた人の構造

3 人格の測定

人の人格を理解し、その情報を教育や臨床場面で利用しようとする場合は、特に情報の客観性に最大限配慮する必要がある。このような目的で様々な人格測定法が開発されているが、ここでは人格検査を中心に説明していく。人格検査は、**質問紙法**、**作業検査法**、**投影法**に大別される。

(1) 質問紙法

質問紙法は最も一般的な検査であり、人格特徴を示す多くの質問項目に対して、自分がどのように当てはまるかを判断し、「はい」「いいえ」などの少ない選択肢の中から選ぶという形で反応を求めるものである。検査によって測定しようとする人格特性の種類と数、質問項目数は多様であるが、各項目に対する回答結果を数値に置き換えて集計し、目的とする人格特性を数量的に表示する点は共通している。多数の人格特性にわたって測定するものは、結果をグラフ化したプロフィールで示すことも多い。

質問紙法は実施が容易で短時間に多くの資料を集めることができることや、結果表示が客観的で解釈法も明瞭であるなど利点は多い。また人格理論や統計的分析に基礎をもつものが多いので、一般に測定概念の妥当性や検査結果の信頼性が高く他人との相違を偏差値等で適切に数値化し、客観的に比較するための標準化が進んでいる。しかし、自己判断に基づく結果なので、回答に意識的あるいは無意識的な歪曲が生じる可能性と、本人に自覚された特性しか測定できないという短所も指摘できる。

① YG性格検査(矢田部ギルフォード性格検査)

YG性格検査はギルフォードの研究を基礎に、**矢田部達郎**が日本人用に作成したもので、適性検査など様々な領域において頻繁に利用される検査である。測定する特性は社会的(外的)適応に関連した12特性で、それぞれ10項目ずつが均等に配列された120問で構成されている。「はい」「いいえ」「どちらでもない」の3件法で回答された結果は特性ごとに集計され、**プロフィール形式**で示される。また、12特性の得点の組み合わせから、図表4-6に示した5つの類型で性格を理解することもできるようになっている。

類 型	特 徴
A型(平均型)	全体的調和がとれており、臨床的には特に問題はない
B型(不安定積極型)	情緒不安定、社会的不適応、活動的、性格の不均衡が外に出やすい
C型(安定消極型)	おとなしい、消極的だが安定している、内向的
D型(安定積極型)	情緒が安定しており、社会適応もよい、活動的で対人関係もよい
E型(不安定消極型)	情緒不安定、社会的不適応、非活動的、内向的、神経症傾向がある

図表4-6 YG性格検査の5類型と特徴



フロイトの心的装置論を発展させてバーンの**交流分析(TA)**理論に基づいて、デュセイはエゴグラムという自我状態表示のためのプロフィールを開発した。完成された人格検査として標準化のなされたものではないが、様々な領域で利用されている。ここでは人格の機能は「批判的な親」「養育的な親」「大人」「自由な子ども」「順応した子ども」の5つに分類され、それぞれの程度を測定する10項目、計50項目の質問に答えて、結果をグラフ表示して自我とエス、超自我の機能の仕方のバランスをとらえようとする。

② MMPI (ミネソタ多面人格目録)

MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) は精神病理学的不適応を識別することを目的として、ミネソタ大学のハーザウェイとマッキンレイによって作成された。これは人格特徴を多種多様な角度から把握でき、質問紙法の欠点を補う方法が用意されている人格検査である。質問は、550項目で構成され、結果は4つの妥当性尺度と図表4-7に示した10の臨床尺度で示される。回答は3件法である。**妥当性尺度**は検査結果の信頼度を検証するためのもので、意識的あるいは無意識的な回答の歪曲や、不注意な回答をした場合にチェックできるようにになっている。臨床尺度のほとんどは診断名が尺度名とされており、ある尺度の得点が高いことは、その診断が下された患者のもつ態度や行動、意識などとの類似度が高い性格であることを意味している。この検査の特徴は、質問項目が多いこと、質問の中に「詩が好きですか?」などの問題があり、具体的に理解しやすいこと、その上、これが一体何を調べているのか見当がつかないように問題に工夫がなされていることである。

	尺度と略号	尺度の高得点の意味
臨床尺度1	心気症 (Hs)	身体機能や心的状態に関する過度の関心と心身の固着傾向
2	抑うつ性 (D)	活動水準が低く、自信や意欲に欠けるといった抑うつ状態
3	ヒステリー性 (Hy)	心的葛藤から逃避して生じる心身機能障害、ヒステリー症状
4	精神病質的偏り (Pd)	反社会的逸脱行動、家庭内葛藤、敵意といった精神病質人格
5	性度 (Mf)	基本的興味の異性方向への偏り
6	偏執性 (Pa)	過度の感受性とさい疑心、自己中心性、妄想性
7	精神衰弱性 (Pt)	不安、恐怖症、強迫観念の程度
8	精神分裂性 (Sc)	自閉的あるいは偏倚した思考や行動という精神分裂病的傾向
9	軽躁性 (Ma)	思考や行動の活発さ、一般的活動水準の高さ
10	社会的内向性 (Si)	社会的活動からの引きこもりと社会への興味の低さ、内向性

図表4-7 MMPIの尺度と意味

● MMPIから生まれた検査

550項目から成るMMPIからは、検査目的や実施条件に合わせて様々な検査が作り出されている。例えば、MMPIの質問項目から不安に関する50項目を抜粋し、それに緩衝項目を加えて**MAS (顕在性不安尺度: Manifest Anxiety Scale)**がテラーによって開発された。MASの児童用はCMASまたはCMAとよばれている。また、MMPIの短縮版としては、250項目から成る**MINI**、さらにその短縮版の**MINI-124**などがあり、コンピュータによる自動診断システムが開発されている。

③ MPI (モーズレイ人格目録/モーズレイ性格検査)

MPI (Maudsley Personality Inventory) は人格の特性論で既述した、**アイゼンク**の研究の基本的な人格特性である**内向性—外向性 (E)**と**神経症的傾向 (N)**の2つを測定することを目的とした検査である。前者は社会性に、後者は情緒安定性と深い関わりをもつ特性であるので、対人関係の在り方を理解するのに適している。2つの尺度はそれぞれ24項目を含み、さらに**虚偽発見尺度 (L)**の20項目、検査目的をあいまいにするための**緩衝項目**12項目を合わせた80項目で構成されている。

ちなみに、MPIの名称は、アイゼンクが勤務していたモーズレイ病院に由来する。また、MPIの改良版として、衝動のコントロールという次元を加えたEPI (Eysenck Personality Inventory/アイゼンク人格目録) が作成されている。

④ EPPS (エドワーズ個人的傾向目録)

EPPS (Edwards Personal Preference Schedule) は、エドワーズが人格の側面である欲求の強さを多面的に測定するために作成した検査である。TATの開発者として知られるマレーの欲求理論を基礎として、達成、追従、秩序などの15の欲求特性の強さを測定する合計225の質問項目で構成される。この検査は被検査者の価値判断が入らないように、また、回答が叙述文の社会的望ましさの程度によって影響されることをコントロールするための工夫がなされている。

(2) 作業検査法

人格の影響が現れやすい一定の作業(精神作業)をさせて、その作業の過程と作業量、正確さなどから人格をとらえようとする検査の総称である。**内田クレベリ**

ン精神作業検査がそれに当たる。

クレペリンが考案した連続加算法を採用して内田勇三郎が作成した検査である。ランダムな一桁の数字が横に何行にもわたって配列された用紙を使用し、被検査者はその隣接する数字を加算して得た結果の一桁部分を中間に記入していく。検査者の号令に従って1分ごとに行を変え加算作業を行い、15分の作業(前期)後、5分間の休憩をはさんで、再び15分間の作業(後期)を行う。被検査者には作業を迅速に行うよう指示される。検査終了後、各行における作業の最終点を線で結んで曲線を描き、この作業曲線の型、全体の作業量水準、誤答の有無と分布を総合的にみて人格特徴を判定する。

(3) 投影法

投影法に分類される人格検査においては、直接的な観察の困難な人のこころの特徴が、外の観察可能な反応の中に反映されていると仮定する。あいまいな刺激に対して意味付けを求めると、人はその中にその人の人格を反映した意味を付与する。例えば青空に浮かぶ雲を見て、空腹な人は食べ物で連想し、子どもは動物で連想するかもしれない。用いる刺激、求める反応の違いによって、様々な投影法検査が開発されているが、いずれも実施に習熟が要求され、解釈に主観が混入しやすいなどの問題点をもつ。しかし、本人も自覚しないような無意識的で力動的な人格の側面に注目したいときには、他の方法では得られない情報を得ることができる。

① ロールシャッハ・テスト

ロールシャッハが考案したテストで、左右対称のインクのしみ(インクプロット)が描かれた10枚のカード(5枚はモノクロ、2枚は赤と黒、3枚は多色刷り)を使用する。順番に提示される刺激に対し、何に見えるかを被検査者が見えた通りに言語的に表現することが課せられる。検査終了後、言語反応のすべては「どこ」を「どのような特徴から」「何に」見えたのかを、記号化(スコアリング)の過程を経て整理され、最終的に各記号の出現頻度や反応時間、反応数などから人格特徴を診断していく。この検査結果から、外界とのかかわり方、欲求、情緒の処理の仕方、現実吟味力などの情報がもたらされる。

② SCT(文章完成検査)

SCT(sentence completion test)とは文章完成法という手法を用いた検査で、被検査者に完全でない文章の書き出し部分を示し、続きを文章で自由に補って完成させるものである。エビングハウスが知能検査の一種として開発したのが最初で、後にペインが人格検査として位置付けた。不完全な記述は被検査者の情動が多面的に喚起されるように工夫されており、この個人的補足部分にその

人らしさが投影されていると考える。

SCTの手法を用いた具体的な検査名称として、20答法またはWAIテストが知られている。「私は子どものころ……」などで始まる20通りの文を完成させるもので、自己概念を測定するのに適している。より早い段階で答えられた内容ほど、被検査者がとらえているアイデンティティとしての重要度が高いとされる。

③ TAT(主題統覚検査)

人がどのような欲求や動機をもっているかを知ることが人格の理解であると考えたマレーは、自己経験や行動観察、作品や心理テスト、既成の理論などの情報をまとめて、人間のもつ多くの社会的動機づけのリストアップを行った。そのマレー自身の理論に基づいて考案されたのがTAT(Thematic Apperception Test)である。主題統覚検査と訳され、あいまい性をもつ人物を含む場面が描かれた30枚の絵と1枚の白紙を順に用いて、空想の物語を述べさせる。そのため同じ投影法であるロールシャッハ・テストよりもTATはより意識水準が高く、しかも対人関係の側面についての情報が得られる。統覚とは多数の心的内容を統一的に結合するはたらきを指す。ここで展開される主題には、被検査者の内発的な欲求と環境の圧力との力動的結合関係が投影されると考える。なお、TATは一般的な意欲を指す達成動機の個人差を測定する道具としても使用されることがある。なお、幼児・児童を対象としたCAT(Children's Apperception Test)がベラックによって作られている。CATは児童統覚検査と訳され、図版には、幼児が感情移入しやすいように、擬人化された動物が描かれている。

④ PFスタディ(絵画欲求不満検査)

PFスタディ(Picture-Frustration Study)はローゼンツヴァイクが欲求不満反応の研究のために考案した投影法で、絵画欲求不満検査とよばれている。冊子の中に、日常誰もが経験する可能性のある欲求不満場面が線画を用いて24種描かれており、いずれも左側の話しかけている人物が右側の人物に不満をおこさせている。被検査者の判断で右側の人が答える言葉を吹き出しに書き込んでもらい、その反応を外罰傾向、自責傾向、無罰傾向の3種類に大きく分類し、性格を診断するものである。

⑤ ソンディ・テスト

ハンガリーの精神科医ソンディが開発した。性衝動、発作衝動、自我衝動、接触衝動の4つの衝動を仮定し、これをもとに8つの衝動要因を設定した。そして、それぞれの要因に対応するという1組8枚の顔写真を6組用意し、各組から最も好きな顔、最も嫌いな顔を選ばせる。その選択内容をもとにパーソナリティを分析するという検査である。



⑥ バウム・テスト

投影法の中でも、紙面上に自由に描画表現させる検査群を**描画法**とよび、言語表出が困難な者にも実施可能な点が特徴である。その代表例が**コッホ**によって考案された**バウム・テスト**である。バウムとはドイツ語で樹木を意味する。A4版の白い画用紙と柔らかい鉛筆、消しゴムを与えて「実のなる木を描いて下さい」と教示し、検査者は描く過程の観察も行う。樹木は地面に対して直立し展開するという性質から、自己像が投影されやすいと考えられている。また、筆跡や紙面の使い方からも個人の性格特徴を分析できる。

⑦ HTPテスト

HTPテストはhouse-tree-person testの略称である。バウム・テストとともに**描画法**に分類される投影法の検査で、バックが考案した。文字通り、家と木と人を描くが、一つずつ別の用紙に描かせる場合や、1枚にすべて描かせる場合など、実施方法は様々である。近年は人を男女各1名描かせることもあり、その場合はHTPPテストとよばれる。いずれも子どもにとってなじみ深いもので、あらゆる年齢層の被検査者が受け入れやすいという点が特徴である。また、結果からは、被検査者の自己像、感受性、成熟度、柔軟性、知的機能、外的世界とのかかわりについての情報を得ることができる。

(4) 観察法、面接法

これまでに述べてきた人格検査は、人格を客観的にとらえることに重点がおかれるため、人を一定の時間、拘束し統制する必要がある。しかし人格理解の対象が子どもや病者であるときは、このような統制が適さない場合も多い。そこで用いられるものが観察法及び面接法である。

観察法は自然観察法と実験観察法に大別されるが、特に教育現場で重要となるのは自然観察法である。自然観察法は、人を比較的自由度の高い状況下において、定められた観点で行動を記述し、その資料に基づいて人格を理解することを目指す。特に、その人が日常生活をしている場面を観察の場とする場合には、自由な本来の姿に接することができるが、観察者の存在を過度に意識せず、また、主観を持ち込まないようにすることに配慮する必要がある。

面接法は他の資料では得られないような豊富な情報を、面接者の意図に応じて収集するのに適している。閉鎖的な面接室において、あらかじめ質問項目を用意しておく**構造化面接法**、その場の人間関係に応じて自由な展開がなされる**自由面接法**があり、両者を折衷した**半構造化面接法**もよく用いられる。被面接者は一般に面接状況での緊張が高まっているので、面接者との間でラポール(信頼関係)を

形成しておくことが必要である。

(5) 検査結果の利用

人格理解には様々な方法があり、それによってとらえられる側面や水準は多様である。したがって検査を利用する際には、それぞれの検査法の限界に配慮しつつ、互いに補完するような複数の方法がとられなければならない。このように複数の検査を組み合わせる総合的な診断を行うことを**テスト・バッテリー**という。例えば、被検査者の意識的な自己認識をとらえる質問紙法と無意識面を探る投影法による意識や力動水準での補完、社会適応性検査と知的傾向を測定する検査による人格側面の補完などが考えられる。

診断結果は慎重に取り扱われることが大切である。臨床や教育上の目的をもった専門家が、ある人の成長を目指したはたらきかけの方針を立てる上での根拠として用いられるべきであり、それ以外の場への情報開示は専門家の守秘義務に抵触することになる。また被検査者本人に結果をフィードバックし自己理解及び自己管理の資料として利用する場合もあるが、フィードバックの方法によっては本人の自己評価を下げる要因にもなるので注意を要する。

4 欲求

(1) 欲求理論

人の身体の内外部の変化によって均衡状態が崩れると、もとの均衡状態に戻そうとするはたらきが身体の中で生起する。キャノンはこのはたらきを**ホメオスタシス**とよんだ。それを具体的に示したのが「3 学習の理論」で述べたハルの動因低減説であった。すなわち、行動の開始を駆り立てる動因や動機が生じ、行動が完成されることで解消する。このような、行動を引き起こす要因となるものを欲求と表現する。

① 欲求の分類

人の欲求は一般に、生命維持や種の保存に関係した生理的な基礎をもつ**生得的欲求**と、生命維持に直接的には関係しない、経験を通じて形成され主に社会の中で自己を位置付けようとする**社会的欲求**に大別される。前者は**一次的欲求**、基本的欲求、**生理的欲求**ともよばれ、摂食、睡眠、性などのように、人間が生存していくのに必要な欲求がここに分類される。また、後者は**二次的欲求**、後天的欲求、派生的欲求ともよばれ、達成、親和、承認、攻撃、依存などのよう

に、人間の社会生活の中で必要となる欲求が挙げられる。

② マズローの欲求階層説

マズローは、人間の諸欲求は階層的な秩序をなして、優先権をもった欲求を満たすと次の階層の欲求へと向かうと考えた。彼の考えは図表4-8に示したように、一次的欲求(生理的欲求)に関わるものは、階層の基底層(第1層)をなす生理的欲求と第2層の安全欲求であり、二次的欲求(社会的欲求)が第3層の所属・愛情欲求と第4層の承認・自尊欲求である。この4つの層は欠乏欲求とよばれ、下位の欲求が充足されないと上位の欲求が生じない。これらのすべての欲求が満たされると最も高次の欲求である自己実現欲求(成長欲求)が生じる。



図表 4-8 人間の欲求階層説

自己実現とは、自分がもって生まれた潜在的な可能性を顕在化させていくことを指す。自己成長や創造活動が進むようになり、有能感や自己決定感などの自己価値が意識されるようになる。自己実現欲求が成長欲求とよばれるのは、自分が成長しつつあるその瞬間においてのみ充足されるからであり、成長した後にもさらなる成長を目指そうとするので、自己実現には完成がないといえる。この点で、4つの欠乏欲求とは性質が異なる。

(2) 欲求と行動

① 欲求と誘因

欲求行動は外的対象に向かうことによって成立する。この対象を、**誘因**とよぶ。欲求と誘因は相互依存的な関係にあり、どちらが先行するかは考えにくい。

誘因は行動の方向と強さを直接的に規定する。前者は目標のもつ誘意性に関係し、後者は目標達成の困難度に関係している。お金や名誉など正の誘意性をもつ対象の場合は接近行動が、危険などの負の誘意性をもつ対象の場合は回避行動が生起する。また目標への距離が近いほど強い接近あるいは回避行動を生起させる。特に、負の誘意性の場合は行動の強さが目標への距離に大きく依存し、正の誘意性の場合よりも急激な行動の強さの変化を示す(図表4-9)。

② 欲求不満と欲求不満耐性

欲求が生じていながら満たされないでいる状態を**欲求不満**(フラストレーション)の状態という。この状

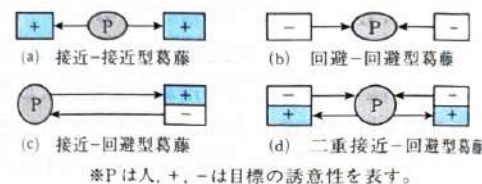


図表 4-9 誘因と行動の関係

態が持続すると一般に心理的に不適当な反応をきたしやすくなるが、**PF**スタディの開発者でもある**ローゼンツヴァイク**は、不適当な反応を生じることなく耐え得る能力もしくはその限界を**欲求不満耐性**とよんでいる。耐性の個人差は大きく、発達の初期の段階で適度な欲求不満を経験し、これになれば、対処法を学習することによって形成されると考えられている。なお、次節で解説する適応機制(自我防衛機制)は、欲求不満への対処法の一つといえる。

③ 葛藤とその分類

欲求は様々な様式で複数同時に存在するのが普通である。これらの欲求が互いに競い合い、対立して、一方の欲求を満たすと他方が満たされない状態を**葛藤**(コンフリクト)という。ゲ



図表 4-10 葛藤の型

シュタルト心理学者で場の理論の提唱者でもある**レヴィン**は、葛藤を「接近-接近型葛藤」、「回避-回避型葛藤」、「接近-回避型葛藤」の3つの型に分類した。

接近-接近型葛藤は、2つ以上の目標がともに正の誘意性を持ち、同時にかなえることができない場合である。レストランへ入って、メニューを前にして食べたいものがたくさんあって決まらないような場合である。**回避-回避型葛藤**は、2つ以上の目標がともに負の誘意性を持ち、どちらも避けたいがそれができないという場合である。勉強はしたくないが落第するのも嫌だという場合である。**接近-回避型葛藤**は、ある欲求の対象が同時に正と負の誘意性をもつ場合で、近道をしたいが嫌いな犬の前を通らなければならない場合がこれに当たる。

なお、これらレヴィンの分類した3つの型に「二重接近-回避型葛藤」を加えて、4つの型に分類する場合もある(図表4-10)。**二重接近-回避型葛藤**は、日常生活によくみられるもので、同時に2つの目標が提示されるが、どちらも正と負の誘意性を備えている場合である。ある女性が結婚相手の選択において、Aさんは経済力は高いが性格が暗く、Bさんは経済力は乏しいが明るい性格であるとき、両者のどちらが自分の結婚相手として適切かを決定できないでいる場合がこれに相当する。

このような葛藤に直面すると、強いストレスにさらされて逡巡行動が多くなり、行動の選択ができた場合でも後に後悔を残したりすることもある。しかし、葛藤を克服する過程で、今までの考え方が変化したり、別の選択肢を自ら生み出したり探し出したりして、新たな適応へと向かっていく可能性も開かれているのである。

5 適応と適応機制

適応とは、人が自らの欲求を満たしながらも環境と調和している状態、あるいは調和を図ろうとする過程をいう。通常、欲求のすべてを満たすことはそのときの社会的状況や個人的価値観にそぐわない場合が多いので、いかに欲求を満たすかということが適応に関わってくる。

(1) 社会的適応と自己適応

自己の欲求の充足と社会的状況からくる要請との間で調和が保たれていることを**社会的(外的)適応**といい、自己の欲求と自己の価値観や目標といった内的枠組みとの間で調和が保たれることを**自己(内的)適応**という。社会的に適応できている状態では、所属集団への同一化が高く、対人関係が安定し、社会規範が遵守され、そのために他者からの評価も高くなる。一方、自己適応している状態では、自己評価や自己受容の水準が高く、充実感や自己存在感、自己効力感が高いといった、肯定的な自己像が形成される。人間の健康を考える上で、従来は社会的適応が重要視されてきたが、近年自己適応にも重要な意義が認められるようになっていく。

(2) 適応機制(自我防衛機制)

適応機制(自我防衛機制)はフロイトの心的装置論を背景に構成された概念である。自我はエスの表出と外界との調和を図りながら現実的に適応する機能を担うが、ときに過大な負担に直面すると、必ずしも適切とはいえないが自我の破綻を逃れるための仮の手段をとって衝動を制御しようとする。このような自我による非常手段的な機能を総称して適応機制もしくは自我防衛機制という。具体的には以下の13機制が考えられている。なお、①～⑨を**防衛型(防衛機制)**、⑩～⑫を**逃避型(逃避機制)**、⑬を**攻撃型(攻撃機制)**として分類することもある。



イソップ物語で、キツネはおいしそうなぶどうを食べようとしたが高い位置に実っていたために手が届かない。それを認める事は耐え難いので「このぶどうは酸っぱいから自分は食べない」と負け惜しみを言った。合理化の機制を示す例としてこの「酸っぱいぶどう」の機制はよく取り上げられる。

① 合理化

自分が行った失敗や不満の真の動機について、もっともらしい理由や理屈をあげて弁解したり正当化したりする機制を**合理化**という。真の動機が自分の無能や不徳など、自尊心を低下させるものである場合に生じやすい。理屈づけともいう。

② 投射(投影)

自己の内に存在する認めがたい欲求や感情を自分から排除して、他者がもっていると認知する機制を**投射(投影)**という。他者に対して敵意をもつ者は、「自分は心の狭い人間だ」というような自己価値の低下をきたさないためにそれを投射し、相手が自分に敵意を抱いていると感じる場合が多い。

③ 取り入れ

ある対象と強い結び付きを得るために、態度、思考、性格、行動などを自己のものとして取り入れて行動すること。例えば、好きな人のしぐさを無意識にまねるなど。

④ 同一視(同一化)

実現したいと思っている能力や価値を満たしている他人と自分とが同一であるように思い込んで満足すること。例えば、憧れているアイドルに自分を重ね合わせ自分の価値が高まったように思い込んで満足するなど。

⑤ 抑圧

自分の安定を脅かすような不満や葛藤などの原因となる欲求や動機は、**無意識**の世界に押しやる機制を**抑圧**という。自己の価値観に照らして認めがたい衝動や自尊心を傷つける観念、不快な体験などが抑圧されやすく、そのような傾向を自分はもち合わせていないかのように感じるようになる。

⑥ 補償

ある面における自己の不満を補うために、他の面で努力を払って満足を得ることを**補償**という。社会的承認欲求が阻害された場合に生じやすく、例えば身体上の問題で異性からの評価を得られない男性が、学問に打ち込んでよい業績をあげる場合が考えられる。



フロイトの精神分析理論の影響を強く受けた個人心理学者のアドラーは、コンプレックスの上位概念として**劣等コンプレックス**について述べた。人間は自己に存在する劣等要素を認めないようにする傾向があり、それが無意識に抑圧されてコンプレックスとして作用すると考えた。日常語としてのコンプレックスは劣等感と同義とされ、このアドラーの劣等コンプレックスを指していると考えられる。アドラーは、この劣等感を補償しようとしてより強くより完全になろうとする意志のことを「**権力への意志**」と名付けた。

⑦ 代償

ある目標を達成しようという欲求がかなえられないとき、その欲求が向けられている対象と類似した別の対象に置き換えることで欲求不満の解消がなされる場合を**代償**という。また、ある対象に向けられていた関心や感情が自分にとって受け入れやすい人や集団、組織あるいは物に置き換えられることを**置換**(置き換え)とよぶこともある。さらに、本来他者に向けられる攻撃が自己に向けられる場合を自罰という。

⑧ 昇華

社会的に許容されない性的欲求や攻撃欲求が社会的、文化的に価値の高い目的に向けられ、努力することを**昇華**という。性愛が芸術、攻撃性がスポーツに昇華されることが多い。社会的適応からみて、昇華は最も望ましい防衛機制の一つであると考えられる。

⑨ 反動形成

自己のある弱点に対する非難を避けるために、これと正反対の行動や態度をとることを**反動形成**という。攻撃的衝動の強い人が過度に謙遜的になったり、憎しみを抱く対象を過度にかわいがったりすることがこれにあたる。

⑩ 退行

解決することが困難な状況で、自我が合理的な対処法を放棄して、より未発達な段階に逆戻りすることを**退行**という。この段階では自我は適応の要請から免除され、自己非難を回避することができる。遊びや芸術活動などによって一時的に退行を生じ、葛藤から解放されて健康を回復する自律的退行と、過去のしこりが残っている時点まで戻って神経症的な人格が固着した病的退行などがある。

⑪ 逃避

困難な状況から逃げることによって不安から逃れようとする消極的な機制を**逃避**という。他人を避けて孤立する退避、空想の世界で満たそうとする空想への逃避(白昼夢)、病気になることで現実の困難をまぬがれようとする疾病への逃避、直接関係のない他の行動に熱中する現実への逃避がある。

⑫ 固着

一定の感情や行動様式あるいはその対象が固定して、流動性を欠く状態を**固着**という。それを繰り返すことで課題や葛藤から逃れて気を紛らすようになる。

⑬ 攻撃

破壊的行動や反抗的態度により欲求不満を解消する機制を**攻撃**という。特定の人物を罵倒したり、物に八つ当たりしたりする場合もあれば、自傷行為などのように攻撃が自己に向けられる場合もある。

6 不適応行動

(1) ストレスと神経症

ストレスとは自律神経系に変異を生じさせるような生理的・精神的緊張負荷状態を指す。葛藤のために行動選択ができない状態はストレスのかかった状態であると考える。日常的にストレスと表現する場合、そこでは一連の過程における3つの側面が含まれていることが多い。第一の側面は、「私は職場の人間関係がストレスです」というような場合で、これは**ストレッサー**(**ストレス源**)とよんで区別されることがある。第二の側面は、「私は最近ストレスが強いのです」という負荷状態を表す場合である。第三の側面は、「私はストレスで眠れないのです」というように**ストレッサー**によって引き起こされる心身の緊張状態で、これを**ストレス反応**とよぶ。ストレス反応として消化性潰瘍や本態性高血圧などの心身症、神経症などが誘発されるが、ストレス負荷やストレス反応の生じ方には個人差が大きい。

神経症は一般にノイローゼとよばれるものに近い。神経症は、医学的には機能的な精神異常状態もしくは身体症状を指し、脳や神経系の器質的な異常が想定されない場合をいう。特徴として、その人の過去経験と症状との間に因果論的結合があり、それらの関連性が意味的に了解可能な上、その結合はその後の経験(精神療法など)によって変化を起こすことが可能なことなどが挙げられる。主症状から、**不安神経症**、**ヒステリー**、**恐怖症**、**強迫神経症**、**抑うつ神経症**、**離人症**、**心気症**などに分類されてきた。なお、**心身症**は、身体症状を主とし、その診断や治療に心理的因子についての配慮が特に重要な意味をもつ病態と解して神経症とは区別する。

●コーピング

ストレスに対する健康的な対処方法を**コーピング**とよぶ。ストレスのコーピングには、気晴らしなどによって苦痛の軽減を目指す情動焦点型と、環境や自分自身の問題を解決しようとする問題焦点型がある。コーピングの実行を規定する要因としては、本人の対人関係形成能力(ソーシャル・スキル)や周囲からの有形無形の援助(ソーシャル・サポート)などが挙げられる。特にソーシャル・スキルについては学習可能であり、**アサーション・トレーニング**などの集団精神療法が開発されている。

(2) 不適応行動の分類

不適応行動とは、社会的環境あるいは自己の内面に適さない行動や反応の総称である。適応の項でみたように自己適応よりも社会的適応が重視されてきた経緯から、一般に不適応行動は、非社会的行動と反社会的行動の2つに分けられる。

非社会的行動は、自分の社会的立場を無視した個人的・消極的行動のために、間接的に社会に悪影響を与える場合を指す。例えば極度の引っ込み思案、不登校、緘黙などの情緒的な問題がこれに含まれる。通常、彼らは社会の秩序を乱そうとする意図をもたず、むしろ過剰なまでに社会的に適応しようとして自らを追い詰めた結果として、社会的不適応のみならず自己不適応にも陥っているケースさえみられる。

一方、**反社会的行動**とは、意図的に社会の秩序を乱したり、道徳・倫理的規範を無視したりする行動である。すなわち、その社会全体に共有されている価値体系からの逸脱行動を指す。一般には、暴力、放火、殺人、いじめや校内暴力などが該当し、狭義には非行・犯罪行動を意味する。

(3) 不適応行動の諸相

不適応行動は極めて広義であり、行動それ自体を分類することと、不適応行動につながりやすい要因を区別して示すことは難しい。以下には、これまで不適応行動の具体的な現象と考えられてきた例を示すが、研究の発展に伴って近年は発達障害に分類されるようになってきているものも一部含まれている。

① チック(チック障害)

チックとは、不意にかつ急速に繰り返される無目的な筋肉の動きのことを指す。幼児や児童の顔面や頸部に生じやすいが、他の様々な部位におこることもある。これまで、神経症あるいは情緒障害の下位概念に位置付けられ、指しゃぶり、爪かみ、抜毛、叩頭や回頭などと同様に神経症性習癖の一つと考えられてきた。そのため、要因として親子関係の問題が疑われてきたが、近年は、脳の器質的な問題が指摘されており、医学的な精査が必要といわれている。

最近では、多発性のチック(**運動性チック**と**音声チック**を特徴とする)として**トゥレット症候群**が注目され、医学的な治療とともに、要因に関する誤解を解くなど、患者とその家族が生活しやすい環境づくりが重視されてきている。また、トゥレット症候群は注意欠陥/多動性障害(ADHD)を併発することもあるため、不適応行動というよりも発達障害の一つとして位置付けた方が理解しやすいともいえる。その場合、一過性のチックも含めてチック障害とよぶことがある。

発声チック

② かんもく 緘黙

正常な言語能力をもちながらも心理的原因によって話せない症状を**緘黙**という。生活の全場面で出現するものを**全緘黙**といい、家庭や親しい友人の前では普通に話すが、知人や先生の前では話せないなど、特定の状況でのみ話せないものを**場面緘黙**という。一般的に後者の方が多く、幼稚園・保育園への入園時や小学校入学時から比較的長期にわたって症状が現れる**学校緘黙**が多い。異常に高まっている緊張(場面緊張)を解くには、悪循環をもたらす叱責を避け、まずは子どもの世界を理解して信頼関係を形成する必要がある。加えて、積極的に適応するために**ソーシャル・スキル**を身に付けさせることが有効ともいわれている。 ex: タブレットで会話する

③ 心的外傷後ストレス障害(PTSD)

近年、心理学において**心的外傷後ストレス障害(PTSD)**が関心を集めている。PTSDとは、post traumatic stress disorderの略称である。例えば、自分の生命の危険、住んでいる家や街が破壊される、親しい人が亡くなるといったように過酷な体験が**心的外傷(トラウマ)**となり、不安や不眠、抑うつ感、疲労、過度の緊張が生じる。また、**フラッシュバック**などによる外傷的できごとの再体験も特徴的な症状として知られている。

約半数は3ヵ月以内に回復するが、教師は心的外傷を体験した子どもへの対応の仕方などを専門家や保護者と連携しながらよく考えていかなければならない。通常のカウンセリングだけで効果がみられない場合、特定の症状に対する行動療法や認知行動療法が有効な場合もある。

④ パニック障害

不安障害の一種で、突然前触れもなく動悸、呼吸困難、めまいなどの発作(パニック発作)を繰り返し、発作への不安によって外出などの社会生活が制限される病気で、治療には薬物療法と認知行動療法などの併用が有効とされている。特に近年、認知行動療法的な指導が行われているケースが多くみられる。子どもの安全と心理的な安定を確保するためには、教師やカウンセラーが子どもの状況を理解し、必要な支援を提供することが重要である。

⑤ 不登校

狭義には、登校したいあるいは登校しなければいけないという意志をもちながら、登校できないで心理的苦痛を体験している状態を指す。近年は、怠学も加えて学校に行かない状態をすべて含み込んだ**不登校**という概念でこの領域の問題を扱おうとする考えが一般的になってきている。

不登校には様々なタイプがあり、様態、不登校理由、経過(予後)、年齢、精神医学的基準などからの分類の試みも多いが、統一的な見解は出されていない。

一般に不登校に対しては、将来の社会的自立に向けて支援するという視点で、無理な登校刺激（登校を勧めること）を与えず、子どもの訴えに耳を傾ける姿勢ではたらきかけを継続することが必要であるが、機械的なはたらきかけによって保護者等を追い詰めることがあってはならない。また、適応指導教室はもとより、民間施設やNPO等との連携ネットワークによる支援にも大きな意義がある。「心の居場所」づくりを基本としつつ、個々の要因に応じた適切な取り組みの充実が求められている。

⑥ 摂食障害

拒食症は思春期前期の女子に特に多く、極度に食事を拒否して体重が激減し、放置すると死に至るなどの重篤な状態に陥るもので、**神経性無食欲症**ともよばれる。一方で、過食して自責的になって吐く行為を繰り返すこともある。この拒食と過食を総称して**摂食障害**という。いずれも身体の成長や健康を阻害する点で共通している。

背景としては、周囲の大人への拒否感が強く、特に異性に対して不潔だといって極度に嫌うなど「大人の女性になりたくない」という成熟拒否願望が指摘され、支配的で完全癖の強い親のもとで、主体性が育っていない場合に多いといわれてきた。しかし、近年は「やせたい」という欲求がきっかけになることも多く、実際はかなりやせているにもかかわらず太っていると思い込んでいる自己身体像（ボディ・イメージ）の歪みが注目されている。

⑦ いじめと自殺

現代のいじめは、集団で弱い者を繰り返し継続的に攻撃し、教師や親に訴えても、その目の届かないところでさらにいじめられるという悪循環に陥る特徴をもっている。さらにいじめの手段がエスカレートし、言葉の暴力や無視に加え、性的虐待や金品強要といった迫害的な人権侵害も少なくない。

従来はいじめの要因としていじめられる側の人格の問題を取り上げることが多かったが、いじめられる心理を誰にも訴えることなく自ら死を選択する中学生が絶出するようになって、いじめと自殺の防止が何にもまして緊急な課題として考えられるようになってきた。いじめ緊急対策会議報告においても、教師は常にいじめがあるのではないかという問題意識をもち、弱者へのいじめは人間として許されない行為であるので、毅然とした態度でいじめは許されないことであると指導する重要性が述べられている。またいじめには**加害者**と**被害者**以外に、現場を見てはやし立てたりする**観衆**と、無関心で背を向けている**傍観者**もいじめに関わっており、これらもいじめを生む土壌を作っていることから、広い意味で加害者の立場に含めて考えるべきであるとされる。

⑧ 非行

トウリュウ犯罪...

子どもの反社会的な不適応行動としての非行は、その様相が近年様々に変化し、学校においても教師が対応に悩む問題となってきた。非行の多くはいわゆる初犯型であり、万引き、自転車窃盗などが該当する。単純な動機から安易に行動に移すことが多いと考えられるが、軽微な犯罪から重大な事件に発展する可能性も高いことを心得ておくべきである。

⑨ スチューデント・アパシー

しばしば青年期、特に大学生にみられる不適応現象を**スチューデント・アパシー**という。無感動・無気力・無関心の特徴とし、特別の理由がないのに学習活動や社会への関心や意欲を失ってしまう現象を指す。また、学業や仕事などの重要な社会的役割（本業）を避けつつも、サークル活動や趣味、アルバイトなどの副業には熱心であることを指す**退却神経症**という概念が我が国で提唱されているが、近年は全面的な退却を特徴とする**ひきこもり**が増えているといわれる。

●バーンアウト症候群

燃えつき症候群とも訳されている。医師、看護師のように、善意で行動すればきりがなく、また、人員不足などによって多忙を余儀なくされている人々が、ある日突然無気力化してしまう症候群をいう。これは休養によって回復できるものであるが、現代社会の非人間的部分を象徴する問題として近年注目されている。教師に対する調査でも、大きな割合の**バーンアウト症候群**がみられており、教職も大変な仕事であることをうかがわせる。

7 発達障害

発達途上において、発達障害とみなされる子どもたちが存在する。健常児と区別するのではなく、彼らの内的世界を理解するように努めることが重要である。ここでは、代表的な発達障害とその一般的な特徴を取り上げる。

(1) 自閉症

自閉症は、小児自閉症としてカナーによって症例報告がなされた発達障害であり、通常3歳頃までに周囲の大人によって発見される。言語発達の遅れが著しくおうむ返しのような表現が多い、よびかけに応答せず視線も合わせようとしない、

対人関係を作ることが困難であること、上半身を前後に揺すったり意味のない日課や儀式に固執したりすることなどを特徴とする。原因としては中枢神経の機能障害が推定され、発達障害の一つに位置付けられる。

●高機能自閉症とアスペルガー症候群

一般に自閉症は知的障害を伴うと考えられてきたが、時として特異な能力を示す者がいる。そこで近年は、自閉症の中で知的発達の遅れを伴わないものを指して**高機能自閉症**、さらに自閉症の特徴のうち、知的発達が保たれ言語発達の遅れがみられないケースを**アスペルガー症候群(アスペルガー障害)**とよんでいる。ただし、これらの区分は厳密なものではなく、自閉症の連続体(自閉症スペクトラム)として考えることが基本である。

(2) ダウン症

ダウン症(ダウン症候群)は、21番目の染色体が通常より1本多い21-トリソミーに代表される**常染色体異常**によって生じ、精神や運動の発達の遅滞、筋緊張の低下などがみられる。また、合併症として心臓などに先天性疾患をもつ例もあり、感染症など種々の疾患に注意を要することがある。一般的に性格は温厚で社会性の発達はよく、豊かな共感性や模倣意欲をもっている。

●染色体異常

染色体異常は、常染色体異常と性染色体異常に分けられる。ダウン症は第21染色体のトリソミー(3倍体)であるので常染色体異常に分類される。性染色体異常では、X染色体が1本しか存在しないターナー症候群(低身長を主症状とし、女性のみが生じる)、XXYやXXXXYなどX染色体が多いクラインフェルター症候群(長身や女性化乳房を主症状とし、男性のみが生じる)が知られている。

(3) 学習障害(LD)

知能に全般的な障害はないが、読み・書き・計算・概念形成などの特有な能力の習得や使用に著しい困難をきたすことを主症状とし、中枢神経の機能障害に基

づくと思われるものを**学習障害**といい、LD(Learning Disabilities/Disorder)と称される。単に学習成績が低いことを意味する学業不振児や潜在的な能力に見合う学力が達成されていないアンダー・アチーバーとは区別される。

LD児は時に落ち着きのなさ、情緒不安定、注意集中困難などを示すことがあるが、それは以下に述べるADHDとの併発例が多いからである。なお、LDの診断に用いる検査としては、カークらによって開発されたITPAが知られている。

(4) 注意欠陥/多動性障害(ADHD)

不注意な言葉や動作が多発する(注意欠陥)、絶えず落ち着きがなく動き回る、衝動的な言動が頻繁にみられる(多動性/衝動性)などの状態(症状)が6カ月以上続くものを**注意欠陥/多動性障害**という。通称は**ADHD**(Attention Deficit Hyperactivity Disorder)であるが、不注意優位型、多動・衝動性優位型、混合型に分類されるように症状には個人差がある。

通常、これらの症状のいくつかが7歳以前に存在し、著しい不適応が学校や家庭など複数の場面で認められる。周囲だけでなく本人も困難を感じ、何らかのサポートが必要となる。ただし、知的障害(軽度を除く)及び自閉症などが認められないケースを指し、専門的知見を有する者の判断が必要である。

8 病理水準と境界例、精神病

人格的な問題を理解しようとするとき、病理水準によって分類を行うことがある。病理水準とは人格の病理性の程度を指し、具体的には神経症、境界性人格障害(ボーダーライン)、精神病の順で重くなるという区分を指す。重いほど精神症状が激しく患者の認識した世界への常識的な理解は困難となり、内因性で症状形成が心理学的に了解されにくい。

(1) 境界性人格障害(ボーダーライン)

境界性人格障害(ボーダーライン)とは、神経症と精神病の境界上に位置付けられた状態を指す。従来は境界例とよばれてきたが、近年は神経症及び精神病のどちらの範疇にも含まれない独立した精神病理的な状態としてとらえ、境界性人格障害とよばれるようになっていく。症状としては、孤独感から身近な他者に対して過度の理想化と過小評価を繰り返すなどの両極端の感情を向ける激しい対人関係、怒りと抑うつを行き来する極端な気分の変動、衝動性の自己破壊的行為、自殺企図などがみられる。

2) 統合失調症(精神分裂病)

精神分裂病は、クレペリンが早発性痴呆とよんだものをプロイラーが人格の解体を表すために改名したもの(スキゾフレンシア)の邦訳で、青年期以降発症しやすい。妄想(関係一被害妄想)知覚、自我障害、作為体験、幻聴への応答などの陽性症状と、自閉、感情鈍麻、緘黙などの陰性症状が特徴的である。抗精神病薬による薬物治療と心理社会的治療の併用が必要とされている。なお、精神分裂病の名称が差別や偏見を助長してきたとの判断から、日本精神神経学会が2002年に**統合失調症**への名称変更を決定した。

3) 躁うつ病

躁うつ病は、患者の心理は理解可能で、重篤な病理水準に当てはめて理解されることはない。現在は感情障害あるいは気分障害と解される。元来は、悲観や絶望、気落ち、食欲減退など活動性の低下に代表されるうつ状態と、気分の異常な高揚、多弁、観念本逸などの躁状態の双方を含む変動がみられる病態を指すが、近年はうつの様相しか示さない单相(極)性のうつ病が圧倒的に多くなっている。

うつ病の患者は義務感が強く自責的になり、時に自殺へと結び付くこともある。よって、義務からの強制的解放が必要であり、特に周囲からの「頑張れ」という励ましは厳禁であり、医師の指導にしたがって十分に休養をとることが求められる。

tea time



人格の障害を引き起こす原因を示す概念として、心因性、外因性、内因性というカテゴリーがある。**心因性**は、社会的ストレスや衝撃の体験、無意識の葛藤などを基礎として心理的なメカニズムによって生じる場合を指し、神経症や心因反応などが含まれる。**外因性**とは、発熱や外傷などによって脳や神経系に物理的な障害が存在し、それによって引き起こされる精神症状をいう。**内因性**は、心理的な経験や器質的な損傷を主要因としない症状で、厳密には原因不明であるが遺伝的基礎が想定される場合を指し、統合失調症、狭義のうつ病などをいう。

9 カウンセリングと精神療法

前項で人格の不適応について述べてきたが、このような状態にいる人に対してどのように接していったらよいのだろうか。この問題に取り組んでいるのが**臨床心理学**であり、その実践形態が**カウンセリング**あるいは多種多様な精神療法(心理療法)である。臨床心理学は、ある個人のより適応した状態を目指した、診断と治療のかかわりを両輪とした心理学の特殊領域である。最近、このうちの人間的かかわりの態度をより重視して、心理臨床とよぶことが多くなってきている。

また近年は、十分に適応できている人に対しても、より統合された人格への成長を促進するようなはたらきかけが大切であるという認識が広まっている。よって、カウンセリングや精神療法の目的として、**治療**、**予防**、そして**開発(成長)**の3つを挙げることができる。治療を目的とする場合でも、不適応にある人を、病む人あるいは患者という否定的なとらえ方をしないで、一人の人間としての尊厳を最大限に尊重して、自らも同じ人間として関わり合いをもち、ともに成長していこうという姿勢で接することが大切であろう。

●臨床心理士

専門的な観点から心理学的な手段を用いて不適応の人との治療的関わりをもつ「心の専門家」には様々な立場があるが、我が国において特に学校教育の領域で最も広く受け入れられているのが臨床心理士であろう。これは1988(昭和63)年に16の学会の総意により設立された日本臨床心理士資格認定協会による民間資格で、指定大学院の修士課程修了が前提となっている。臨床心理士は、文部科学省によるスクールカウンセラー事業をはじめ、教育、医療・保健、福祉、司法・矯正、労働・産業などの分野で活躍している。

臨床的関わりにおいて知り得たクライアントの情報は、決して第三者に漏らしてはならないし、知る可能性が生じるような事態は回避しなければならない。そこには守秘義務がある。両者の関わり合い自体が、そのような守られているという安心感の中で初めて成立するものだからである。

(1) カウンセリング

カウンセリングは、広義の精神療法に含まれ、特に一対一での話し合い的な処置によるものを指すと考えてよい。起源は、精神医学的な治療よりも教育の分野

に求められ、パーソンズによる20世紀初頭のガイダンス運動(職業指導・進路指導)であるといわれる。ただし、多様なアプローチが存在する今日では、後述する狭義の精神療法との区別は困難であるともいえる。

① 指示的カウンセリング(臨床的カウンセリング)

伝統的に精神療法は精神医学の領域に属すると考えられていたが、20世紀初頭から始まったガイダンス運動が発展して、その中からウィリアムソンによる**臨床的カウンセリング**が注目を集めた。例えば進路相談などで、クライアントが悩むのは適切な情報が不足しているためで、正しい情報を積極的に与えれば自ら解決できると考えられる場合などが相当する。その方法の特徴から**指示的カウンセリング**とよばれている。これはカウンセラー主導のカウンセリングである。

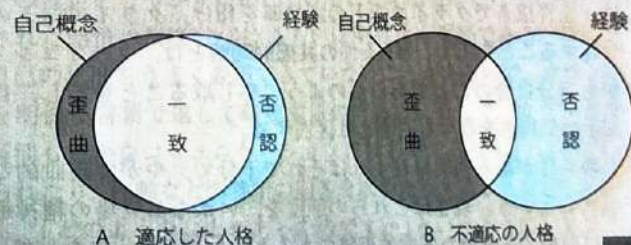
② 非指示的カウンセリング(来談者中心療法)

従来のカウンセラー主導型の指示を与えるカウンセリングに対し、クライアントが自発的に問題を解決して成長していくことの重要性を説く立場を、**非指示的カウンセリング**という。ロジャーズによって提唱され、後に**来談者(クライアント)中心療法**とよばれるようになった。今日、最も広く受け入れられている立場であり、一般にカウンセリングという場合には、ロジャーズの考え方に基づいていることが多い。



自己理論

人が自分自身についてもつ認知を**自己概念**という。ロジャーズは人格の状態を下図に示すような自己概念と経験との関係から考察した。この2つの領域が一致しているほど健康的な人格状態で、一致していない領域が大きいほど不健康な人格状態である。この理論では、カウンセリング等の適切な環境によって人はその自己概念を変容させることができ、経験とより一致するようになるという人格の流動性を強調する。このように人の感覚や経験の世界を重視していく立場を総称して、現象学的自己理論という。



(自己概念と経験の関係)

第1条件	2人の人間が心理的な接触を持っている。
第2条件	第1の人(クライアント)は不一致の状態にあり、傷つきやすいか、不安の状態にある。
第3条件	第2の人(カウンセラー)はこの関係の中では一致しており、統合されている。
第4条件	カウンセラーは、クライアントに対して無条件の肯定的な関心を経験している。
第5条件	カウンセラーは、クライアントの内的照合枠に共感的な理解を経験しており、この経験をクライアントに伝達するように努めている。
第6条件	カウンセラーの共感的理解と無条件の肯定的関心(配慮)をクライアントに伝達することが、最低限度は達成されている。

図表4-11 来談者中心療法における必要十分条件

1) 来談者中心療法の諸条件

ロジャーズは、何が本当の問題で、それはこれからどう変わっていくのかを知っているのは本人だけであると述べ、本人が主体的に自己理解を深めて自己選択していく新しい立場、**来談者(クライアント)中心療法**を主張した。クライアントの**自己成長力**や**自己実現傾向**に全面的信頼をおいたもので、治療が成功するための必要十分条件であるとして6つの条件を提示している(図表4-11)。

第2条件の**不一致**とは、クライアントの経験と自己概念との間に大きなズレがあることを指し、第3条件の**一致**とは、カウンセラーが治療関係の中で自由に自分らしくあり、かつ自己の経験が正確に気付かれ表明されている状態を指し、**自己一致**あるいは**真実性**ということもある。カウンセリングを通して、クライアントも一致へと向かうことが目標となる。

このような状況において、カウンセラーは**無条件の肯定的関心(配慮)**と**共感的理解**によってカウンセリングを進めていく。第4条件の**無条件の肯定的関心**とは、条件抜きでクライアントの話に耳を傾け、クライアントの経験を温かく受容することを指す。第5条件の**共感的理解**とは、クライアントの感情をあたかも自分自身のことであるかのように感じ取ることを指し、自分の視点から相手の気持ちを察する同情とは区別する。

以上の条件がある期間継続すればそれで十分で、やがて建設的な人格の変化が現れるという。現在はこれらの態度を、いかなる立場の精神療法を用いる場合においても有効な基本的姿勢であると考えられている。

●ラポール

ロジャーズに限らず、カウンセリングや精神療法、人格検査、診断面接などにおける、カウンセラーとクライアント、面接者と被面接者など二者間の信頼関係のことをラポールという。本来は言葉による意志疎通性を表すが、ここでは互いが個別世界に触れ合っている、直接に関係し合っていることを意味する。ロジャーズが挙げた第1条件はこれを指しており、あらゆる治療のかかわりが成立するための基本的条件である。

●カウンセリング・マインド

ロジャーズの人間観と治療論を前面に出したかかわりを実行しようとする姿勢をカウンセリング・マインドとよび、カウンセリング以外の教育や医療などの現場においても、教師や医療スタッフが児童生徒やクライアントに対してとるべき態度であると提唱されるようになってきた。すべての人の自己実現傾向への信頼、その人の固有世界の尊重と理解、行動選択における自己決定の尊重などである。実際には子どもたちの話を親身になって聞き、そこに大人の視点からの評価的態度をもち込まないこと、そして理解しようとしていることを相づちなどによって表現・伝達することが大切である。

2) カウンセリング的技法

クライアントに無条件の肯定的関心や共感的理解を伝達する様々な技法がある。例えば、相づちや表情の変化など、状況に応じた非言語的な応答や、クライアントの自己理解と自己決定を促進するようなカウンセラーの応答として言語的な応答もある。以下に、代表的な技法の一例を紹介する。

まず、クライアントが表明した部分の繰り返しが考えられる。これはクライアントの言葉をしっかり傾聴していることを伝えるという意味がある。また、表明された感情の反映(反射)あるいは明確化も重要である。特にクライアントは自己の状況をうまく表現できていないことがあるので、カウンセラー側の理解を明快な言葉で返して確認するのである。そして、カウンセラーの側からの質問も豊かなコミュニケーションには必要であろう。「はい」「いいえ」で答えられたり、年齢などの特定の回答を求めたりするような「閉ざされた質問」よりも、「どのようなことがあったのですか」というように、クライアントの言葉で具体的内容を引き出す「開かれた質問」の方が望ましいといわれる。一

方で、クライアントが自分の心の中を整理する時間として、カウンセラーが沈黙を守ることが意味をもつこともある。

さらには、複数のばらばらな事象や感情の関連付けや、カウンセラー自身の自己開示、クライアントが回避しようとしている問題との対決、カウンセラーによる問題の方向の焦点づけ(フォーカシング)、クライアントの考え方に対する保証などの技法が考えられている。

エンカウンター・グループ

③ 折衷的カウンセリング

ソーンは、事例に応じてロジャーズの来談者中心療法とウィリアムソンの指示的(臨床的)カウンセリングを組み合わせる折衷的カウンセリングを提唱した。折衷の方法には順序があり、カウンセリングの初期においてロジャーズの立場に基づく受容中心の受動的方法を採用し、それによるクライアントの変化が乏しくなった段階から、カウンセラーの主導によって指示的な関わりをする能動的方法へと移行するのが一般的である。

(2) 心理療法

心理学的な手段や技法によって、症状や状態を軽減あるいは除去するものの総称を心理療法という。広義にはカウンセリングも含まれるが、狭義には話し合い的な処置にとどまらないものを指す。以下にそれぞれの精神療法について説明する。

●カタルシス

様々な心理療法があるが、カウンセリングも含めて、一般に心理療法を通してカタルシス効果がみられる。カタルシスとは、浄化作用とも訳され、心の中に抑圧されていた感情や不満を発散することによって精神の安定をもたらすことである。つまり、心の中にたまった感情をはき出すことによって、不快感・不安などを減退させるのである。

① フロイトの精神分析療法

フロイトの精神分析理論に基づいて、主に自由連想法と連想に対する解釈を用い、抑圧された無意識内容、特に幼児期の体験を意識化し、それらを洞察することを通じて、症状が消えることを目的とした治療法である。具体的な技法としては、自由連想法と夢分析(夢解釈/夢判断)が挙げられる。

自由連想法とは、クライアントのこころに浮かんだことをすべて話すように要求して連想を繰り返してもらい、無意識が次第に意識に浮かび上がってくる

ようにするものである。無意識が浮かび上がる過程でクライアントは不安を感じ、連想を停止させてしまう様々な現象が生じるが、これを**抵抗**とよぶ。

夢分析とは、解釈の素材としてクライアントのみた夢を用いることである。無意識の内容は自我機能が緩んでいる睡眠中に、夢の素材やモチーフとして意識上にのぼってくることがある。したがって、夢は無意識の願望の充足であるといえる。しかし、自我機能が緩んではいるものの現実原則と理想原則が機能し続ける自我と超自我にとって直接的な夢体験は耐え難く、検閲という夢の変装作業を経ることになる。この変装として、フロイトは圧縮、移動、視覚化、象徴化、第二次工作などを考えた。夢分析(夢解釈)とは、変装の結果である夢を頼りにして変装のからくりを解説し、純粋な願望をつきとめていくことである。

●転移と逆転移

クライアントが幼児期に親に対して感じた依存や恐怖、嫉妬などの感情をカウンセラーやセラピストに向けるようになり、カウンセラーやセラピストが自分に特別な感情をもっていると誤認するようになる現象を**転移**とよぶ。特に、自由連想法においては、抵抗の原因となることが指摘されているが、抵抗も転移も治療を進める上で有益な手がかりをもたらすことがある。

一方で、カウンセラーやセラピストが日常的に誰かに対して抱いている感情をクライアントに向けるようになる現象を**逆転移**という。逆転移は治療にとって好ましくなく、これを防ぐ意味でも、カウンセラーやセラピストが自分自身の内面を深く洞察し、コントロールすることが重要である。特に精神分析家となる者が養成段階で精神分析を受けることを教育分析という。

② ユングの分析心理学

ユングの考えは無意識を重視する点などで精神分析理論と共通する部分が多いが、ユング派の精神療法という場合には精神分析との異なる部分を強調して説明されることが多い。この立場では、クライアントの夢や空想、絵画などの創造的活動や神話的モチーフを通して、クライアントの無意識のイメージ世界の活性化を図る。すなわちイメージ自体のもつ統合志向性という治療的意義に信頼をおき、イメージを解釈するのではなく豊かにしていくことこそが大切であると考えた。したがって、言語的なイメージの表現能力が豊かでないクライアントには、描画や箱庭、コラージュなどの芸術的創造活動が治療場面に導入されることが多い。

●個人的無意識と普遍的(集合的)無意識

ユングは、無意識の領域を2つに分けて考えたことでも知られる。一つは、過去の体験が抑圧された**個人的無意識**で、フロイトが指摘した従来の無意識に相当する。もう一つは、人類に共通でより深い人格層にある**普遍的(集合的)無意識**であり、精神病者の妄想など病的体験内容と神話や民話との共通点をもとに考え出された概念である。

③ 行動療法

心理学において実験的に確立された**学習理論**に基づいて不適応行動を治療する試みを**行動療法**という。これは外に現れる行動を変えることができれば、自ずと心の内面にも変化が生じるという考えのもとで成り立っている。行動療法という用語を包括的に提唱したのは**アイゼンク**であるが、歴史的には、**ワトソン**の**行動主義**を基礎とする。以下に代表的な技法を紹介する。

1) 系統的脱感作法

ウォルピは、神経症などに対し、不安や恐怖を段階的に克服していく治療法である**系統的脱感作法**を開発した。これは、古典的条件づけが示すように、本来は中立的であったはずの刺激が、不安という特定の反応と条件反射的に結び付くことによって症状が生じていると考える。

具体的には、事前の面接によって不安を引き起こす程度が弱い方から強い方へと順に刺激を列挙した**不安階層表**を作成する。次に、不安を抑制するための弛緩法をクライアントに学習させる。そして、不安階層表に従って最初は弱い方の刺激を呈示し、その刺激によってクライアントに不安が引き起こされるとき、学習された弛緩法によって不安と相対立する反応を起こすことにより、不安を抑制していく。ある刺激が克服されたら、不安を引き起こす程度の強い刺激へと段階的に移行し、最終的には最も強い刺激が呈示されても不安が抑制されるまで進める。ただし、不安や恐怖は必ずしも条件反射的に形成されたものだけではないので、すべての事例で効果が期待されるわけではない。

2) 自律訓練法

シュルツによって考案された、ストレスの軽減を目的とした精神療法を**自律訓練法**という。自己暗示をすることによって、自律神経系のはたらきを自分でコントロールし、リラックス状態を作ることができるようにする。そし

て、最終的には、不安などの心理的反応を弱めることを目的とする。また、心拍数や血圧などの生理反応を本人に知覚可能な刺激として呈示する**バイオフィードバック**と組み合わせる用いられることもある。すなわち、具体的な生理反応の変化という情報を報酬とみなし、オペラント条件づけの原理によって自律反応の安定的方向への変容を強化しようとする立場といえる。

④ 遊戯療法

遊戯療法は一般に**プレイ・セラピー**とよばれ、言語を媒介としたコミュニケーション能力の発達していない子どもを対象に行われるものである。遊びは子どもにとって自己表現の手段であり、遊びを介してカウンセラーとのかかわりをもつことが可能となる。遊びそのものが子どもの衝動や欲求を解放させる効果をもつ一方、遊戯室内での、カウンセラーとの治療的人間的関係の経験が、日常での偏った対人関係を修正したり、人格発達を促進したりする効果をもつと考える。

カウンセラーは遊びを見守るという態度で接する。普段の子どもたちの遊びは大人の統制下でなされており、カウンセラーの非評価的な態度は子どもの不信感を和らげ、二人の間に生き生きとした交流が生じると、自ら成長していく力が発揮されるようになる。精神分析学派の**アンナ・フロイト**や**クライン**は、子どもの遊びを自由連想法と同じように扱って、無意識表現であるとして**カタルシス**（情動解放）の効用を強調した。また、**アクスライン**は来談者中心療法の考えに基づいて遊戯療法を行った。

遊戯室は、様々な活動を誘発するような遊具、砂場や水道、絵画用品、楽器などが備えられた、子どもにとって開放的で広いと感じる空間である。

⑤ 箱庭療法

ローエンフェルドは**遊戯療法**に改良を加え、作品を作らせる技法を発展させた。これは世界技法として知られるようになり、後にユング心理学の影響を強く受けた**カルフ**によって**箱庭療法**が完成され、大人もその対象とされるようになった。

木箱の内側の寸法は57×7×72cmで、中に砂が入れている。木箱の内側は青く塗られており、砂をかき分けて池や川、海を表現することもできる。そして、人、動物、怪獣、木、建物、乗り物、棚などの様々なミニチュア玩具が多数用意されており、クライアントはこの玩具を用いて、自由に箱庭を作る。カウンセラーによって提供された自由で安全な保護された空間の中で、クライアントは創造活動に専念することにより自己治癒力を発揮することができる。また、この活動を通してクライアントの内的世界が展開されるのでクライアントの状態を理解することも可能である。ただし、分析的あるいは理論の当ては

めにならないよう注意する必要がある。また、治療への箱庭の導入においては、クライアントの自由意思を尊重する。

⑥ 認知行動療法

クライアントが行動面の問題だけではなく、考え方や価値観などの認知的な問題も抱えているという観点から、行動的な技法と認知的な技法を効果的に組み合わせることによって改善を目指す精神療法を総称して**認知行動療法**という。

1) 認知療法

認知療法は、ベックにより提唱された精神療法で、認知過程の極端な歪みを修正することによりうつ病やパニック障害などの情緒反応を治療するものである。典型的な歪みとしては、証拠が不十分なまま思いつきを信じ込む恣意的推論、常に白黒をつけようとする二分思考、すべて自分と関連付けてしまう自己関連付けなどがある。主に、自己や環境、将来に対する否定的な認知が治療における焦点となる。

2) 論理療法

論理療法は、エリスによって創始され、**合理情動行動療法**ともよばれる。まず、人の反応は刺激によってのみ生じるものではなく、刺激の解釈などの認知的変数によって生じると考える。そして、問題を引き起こすことに関連する思考スタイルを**非合理的信念**（**イラショナル・ビリーフ**）とよび、これを合理的なものに改めさせることが目標となる。信念の変更に抵抗のある場合には論争を行ったり、問題の生じる場面で実際に合理的信念で行動させるホームワークを課したりする。

⑦ 集団精神療法

様々な理論に基づく精神療法を集団場面で行う場合を総称して**集団精神療法**（**集団心理療法**）という。個人の不適応は社会的場面において端的に現れ、個人の発達は家族、学校、職場の人間関係という集団経験にかかっている。そのような観点から、集団活動を治療理念の基本にすえようとする立場である。

1) 心理劇（サイコドラマ）

モレノは**ロールプレイング**を手段とする、**心理劇**（**サイコドラマ**）を開発した。参加者は集団の場で、監督、助監督（参加者の補助をする補助自我）、役者、観客として即興的にアクションを行い、この中で様々な体験をし、創造性と自発性をはたかせることによって、カタルシスと新しい行動可能性を獲得する。そして、演技を通して自己への洞察や他者との共感を深めることになる。

2) エンカウンター・グループ

ロジャーズが中心となって普及した、対人関係の経験を通じて個々人の成長

と自己開発を目指す集団精神療法をエンカウンター・グループという。現在は、従来のTグループ(感受性訓練)なども含んで用いられることが多い。

エンカウンターとは「出会い」を意味し、日常の防衛的な対人関係の枠を超えて、自由な自己表現と他者受容、それらを基礎として初めて可能となる相互理解、相互信頼を目指し、この経験はより進んだ自己受容をもたらすことになる。通常、性別や年齢、職業の異なる10～15名前後の参加者と1～2名のファシリテーター(世話人)によって構成され、3～5日の合宿形式で実施される。自由な討論を通して、自己理解、他者理解が進み、心理的に成長するとともに、対人関係の改善と発展を目指すものである。

3) その他の集団精神療法

上記以外の集団精神療法としては、「今、ここで」(here and now)の体験と欲求との関係の全体性を重視して、自発的な感情や自己への気づきを喚起するゲシュタルト療法が知られている。これは下述の構成的グループ・エンカウンターにも生かされている。

また、対人関係技能の習得あるいはその改善をめざす集団精神療法を総称して社会的スキル訓練(ソーシャル・スキル・トレーニング)という。その中でも重要な技法の一つに、適切な主張行動の習得を目指す主張性訓練(アサーション・トレーニング/アサーティブネス・トレーニング)が注目されている。ここでいう主張性とは他者の意見、立場などを尊重すると同時に、自分の意見や立場を大切にすることである。これは相手を見捨てて自己の主張を無理やり押し通すことではなく、また逆に自己の主張を表明せずに我慢することもなく、適切な形で相手に自分の意見を伝える技法を学び、建設的なコミュニケーションの促進を図ることを目的とするものである。

●構成的グループ・エンカウンター

近年、ロジャーズのエンカウンター・グループから発展したもので、國分康孝による構成的グループ・エンカウンターが注目されている。これは活動内容や時間などの枠を設けたもので、エクササイズ(課題)と、そこで感じたことを参加者が互いに発表するシェアリング(振り返り)の時間が特徴である。考え方や目的はエンカウンター・グループに基盤がおかれているが、多様な精神療法からも技法を取り入れており、時間的・空間的に制約のある学校や職場での活用を目指した形式であるといえよう。

⑧ 森田療法と内観療法

森田療法は我が国において森田正馬が神経症に適用した精神療法である。治療は段階的な入院治療で、それぞれ1～2週間の絶対臥褥^{せきよく}期、軽作業期、重作業期、複雑な実生活期を経て行われる。絶対臥褥とは、クライアントを個室で隔離臥床させ、食事、洗面、用便以外は離床を認めないものである。最終的に、完璧な自己の追求は意味をもたないことに気づき、ありのままの姿を念頭において自己を振り返ることを目的としている。

また、我が国では浄土真宗の僧侶であった吉本伊信が内観療法を考案している。身近な人との関係を回想するもので、反省、ざんげ、感謝、報恩という内的変化で幅広い症状に有効とされる。

⑨ その他の精神療法

1) 催眠療法

暗示によって理性的思考が緩んで想像の世界に入り、想像自体が現実味を帯びるような意識状態(催眠性トランス)を用いた精神療法を総称して催眠療法という。現実的な事柄からの解放に重点をおいたリラクゼーション催眠療法や、催眠中のイメージ空間における体験を重視するイメージ催眠療法、催眠状態の中で精神分析療法を行う催眠分析など多様なものがある。

2) 短期療法(ブリーフ・セラピー)

短期間で治療を成功させようとする精神療法を総称して短期療法(ブリーフ・セラピー)という。これは従来の精神分析療法が長期間を要し、費用の面で問題があるという背景から1960年代以降のアメリカで発展してきた。具体的には、時間の制限、指示的な関わり、過去よりも現在・未来志向、クライアントの人格的成長よりも問題解決を重視するなどの特徴がある。

3) 家族療法

治療の焦点を個人に当てるのではなく家族集団を研究と治療の単位として扱い、家族というシステムの中で個人の問題をとらえようとする療法を総称して家族療法という。特に家族内での対人関係のプロセスに注目し、本人を含む家族成員の合意が得られた治療目標に従って介入を行う。例えば、不登校の場合に子ども本人だけでなく、親子関係、さらには夫婦関係といった大人自身の危機にも焦点を当て、最終的には家族全体の変容を目指す。

確認問題

12 人格理解における類型論と特性論の特徴を記した次の文の()に適語を入れよ。

(A) 論では、一定の観点から典型的な性格像を設定して、少数の型に当てはめて理解しようとする。(B) は病前性格である分裂気質、躁うつ気質、粘着気質と(C) 型、(D) 型、(E) 型の体格とを関連付けた。ユングは力動論の立場から、(F) が向かう方向によって(G) 型と(H) 型に分類した。

(I) 論では、人格を構成するいくつかの基本的単位に分析して、それぞれの程度を数量的に測定して、それらの組み合わせによって表現しようとする。例えば、キャッテルはこの特性を抽出する際に(J) という統計的手法を用いた。この立場の理論からは多くの人格検査が作成されており、結果の表示はしばしば(K) 化がされる。典型的には、ギルフォードの理論に基づき、12の特性を120項目で測定している(L) が当てはまる。

13 次の文が説明している性格検査の名称を語群から選べ。

- (1) 左右対称のインクのしみが描かれたカードを見て、何に見えるか答えてもらう投影法の検査である。→ エ：ローレシャッハ・テスト
- (2) 1桁の数字の足し算を連続して行わせ作業曲線などから性格を診断する検査である。→ イ：内田クレベリン精神作業検査
- (3) 人物の描かれた絵を見て物語を作ってもらい、そこに欲求や達成動機が反映されていると考える投影法の検査である。→ ア：TAT (主題統覚検査)
- (4) 1本の実のなる木を描いてもらい、そこに自己像が投影されるという描画法の検査である。→ ウ：バウム・テスト
- (5) 外向性—内向性と神経症の傾向を測定する質問紙法の検査で、合計80項目から構成される。→ カ：MMPI

【語群】

- | | |
|-----------------|------------------|
| ア. TAT (主題統覚検査) | イ. 内田クレベリン精神作業検査 |
| ウ. バウム・テスト | エ. ローレシャッハ・テスト |
| オ. MMPI | カ. MPI |

14 次の用語について、それぞれ簡潔に説明せよ。

- (1) PTSD
- (2) アスペルガー症候群
- (3) LD
- (4) 欲求階層説

15 人の適応について述べた次の文の()に適語を入れよ。

(A) の力動論を背景に(B) という概念が構成された。(C) は現実原則に基づき、エスの表出と(D) からの道徳的要請、及び外界の条件との調和を図りながら適応しようとするが、時に破綻を避けるために必ずしも適切ではない非常手段をとることがある。例えば、理屈づけや負け惜しみといわれる(E)、自己の欲求を他者がもっていると認知する(F)、自己の劣等感をカバーするために他の面で努力を払って満足する(G)、本来の欲求が社会的に価値の高い目的に向けられる(H)、自己の欲求と正反対の態度をとる(I)、意識していると苦痛な欲求を(J) へ押し込める(K)、合理的な対処法を放棄して未熟な段階へ逆戻りする(L) などがある。

16 カウンセリングについて述べた次の文の()に適語を入れよ。

現在、精神療法の種類は多様であるが、(A) によって提唱された(B) 療法はあらゆる立場の基礎として広く受け入れられている。もともとは(C) のカウンセリングとよばれ、誰もが自己成長力や(D) 傾向を有していることに信頼をおく。(E) は、自分自身についてのとらえ方である(F) と、実際の状態である(G) とが不一致の状態にあり、カウンセリングによって2つがより(H) の状態に近づいていくことを目標とする。カウンセラーに必要な態度として、カウンセラーが(I) していること、(E) に対して(J) を経験していること、そして(E) の内的枠組みに(K) を経験していることの必要性を挙げた。カウンセリングにおいては、前提条件として2者の信頼関係を意味する(L) が必要である。また、(A) の治療論や人間観に基づく態度は精神療法以外の教育場面においても教師の基本的態度として有効であると考えられるが、この精神を(M) という。ちなみに、(A) は集団心理療法として(N) を提唱したことで知られており、様々な分野でその精神が生かされている。